HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

Infirmier organisateur de l'accueil – Analyse de pratique

M. LAFI
Urgentiste & Chef adjoint – Service des urgences
G. SILVETTI
Infirmier Référent – Service des urgences
E. MARTIAL
Cadre de santé – Service des Urgences

Date

Pour cette formation, nous demandons à chaque professionnel de présenter une situation qui lui pose problème dans sa pratiques au quotidien.

Pour ce faire, nous vous demanderons d'en discuter ensemble et de former des binômes.

Chaque binôme choisira une situation qui entre dans l'un des thèmes suivants :

1 – Médico-Légal (PEC mineur, CNA, GAV, fugue, sortie, agressivité)
2 – Pathologies neurologiques
3 – Pathologies cardiologiques
4 – Pathologies respiratoires
5 – Pathologies psychiatriques
6 – Lien avec l'extérieur (transferts, brancardage, entrée/sortie)
7 - Réorientation

Pour chaque présentation, nous avons préparé trois diapositives qu'il vous suffira de remplir :

1 – La présentation de la situation
2 – La problématique et la solution que vous avez mises en place
3 – Les écrits

Le topo sera présenté au groupe lors de la formation et nous en débattrons ensemble.

Votre présentation doit durera 15 min : 5 min de présentation et 10 min d'échange

Votre présentation devra être envoyée quelques jours avant la formation.
Nous créditerons 2h de hors clinique sur vos Octimes (temps de préparation).
Vous pouvez solliciter à tout moment l'aide ou les conseils de l'équipe d'encadrement (Mehdi, Giovanni où Ericka).

Nous vous remercions pour votre engagement

LA SITUATION

- Présentation succincte de la situation :
  - Contexte
  - Localisation (IOA 1, 2 ou 3 ; Salle d'attente ; Accueil administratif ; ect)
  - Heure
  - Période : Jour / Nuit
  - Motif de consultation du patient
  - …

LA PROBLEMATIQUE

- Qu'est-ce qui vous a posé problème ?
- Qu'est-ce que vous avez mis en place ?
- Comment avez-vous pris en charge le patient ?
- Avez-vous mobilisé des ressources humaines, organisationnels, institutionnels, …

 Ne pas confondre problème individuel avec une problématique globale.

LES ECRITS

- Quels sont les protocoles / procédures du service ou de l'hôpital que vous avez à votre disposition en lien avec la PEC ?
- Existe-t-il des études ? Des écrits ? Des recommandations ? …
- Il y a-t-il un cadre législatif ? Si oui, lequel ?

Situation n°1

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

LA SITUATION

- Homme d'environ 70 ans consulte au SAU. Vu à l'IOA 1 dans la matinée (vers 11h30).
- Patient vivant à Nevers, suivi là bas pour ulcère des membres inférieurs depuis plusieurs mois avec mauvaise évolution et mauvais suivi d'après le patient.
- Consulte à St Jo d'après conseil IDEL après multiples appels et email laissés au secrétariat de médecin vasculaire, en vain.
- Se présente dans ce contexte au SAU, ne sachant pas où aller d'autre et étant de passage sur Paris pour un RDV d'imagerie.
- A l'IOA : pas de signe de gravité de ses ulcères. Pas de cicatrisation malgré soins locaux mais pas de signe inflammatoire. Pas de fièvre, pas d'écoulement purulent etc.

LA PROBLEMATIQUE

J’ai senti à l’IOA que le patient était en errance médicale et avait besoin d’aide.

Régulation par MAO qui me dit que le patient doit se rapprocher du secrétariat de médecine vasculaire donc patient réorienté vers médecine vasculaire avec explications données sur les signes cliniques devant le faire consulter aux urgences (fièvre, rougeur/oedème croissant, sang actif, signe d’ischémie, douleur intense).

Il m’explique qu’il a déjà tout essayé mais qu’il n’a aucune réponse…ne sachant pas quoi lui dire, je lui conseille d’aller se rendre directement là bas pour essayer d’avoir un RDV et programmer une hospitalisation potentielle.

LA PROBLEMATIQUE

Donc :
Ce qui m'a posé problème est que j'ai ressenti que le patient était en difficulté et avait besoin d'accompagnement dans ses démarches mais je me suis sentie limitée sur l'aide que je pouvais lui apporter, j'ai eu l'impression de lui avoir dit de se débrouiller.

Cette situation m'a mise en difficulté : j'avais le sentiment de « ne pas aider » le patient présent physiquement face à moi, tout en devant appliquer la régulation médicale et respecter la mission de l'IOA.

Problématique de temps. Pendant un IOA, sachant qu'il y a du monde qui attend derrière,

Problématique de ressource : qui puis-je appeler pendant ce temps là pour aider le patient ?
Puis-je lui communiquer une information précise sur le lieu, le numéro de téléphone à contacter, les horaires etc ?
(Où trouver ces infos rapidement)

Conflit entre besoin ressenti du patient et mission d'orientation/tri, risque de rupture de continuité des soins, défaut d'informations.

LES ECRITS

- IOA = Infirmier·ère organisateur·rice de l'accueil : c'est un rôle structuré en France, dont l'un des objectifs est d'évaluer à l'accueil, prioriser et orienter les patients vers la filière de soins la plus adaptée (urgence, consultation spécialisée, secrétariat, etc.). L'IOA peut décider de ne pas engager la filière «prise en charge aux urgences» si le besoin n'est pas urgent et d'orienter le patient vers la consultation adaptée.
- Important : cette orientation doit être documentée et expliquée au patient, avec informations sur les modalités d'accès et signes d'alerte à revenir aux urgences.
- La réorientation des patients à partir des urgences est la procédure par laquelle un patient se présentant aux urgences est redirigé par l'infirmier organisateur de l'accueil (IOA) ou par le médecin d'accueil et d'orientation (MAO) vers une offre de santé mieux adaptée à son besoin. Tout patient ne relevant pas de la médecine d'urgence pourra être réorienté, après une évaluation réalisée par l'IOA ou le MAO. La réorientation ne se réalise pas entre services d'urgence, sauf dans le cas où un avis spécialiste non présent dans la structure est nécessaire
- cf protocole SAU Orientation des patients des urgences vers le Centre de consultation Marie Thérèse et Maison Médicale de Garde Bellan.
- Les recommandations (HAS, sociétés vasculaires, EWMA) insistent sur :
  - la distinction entre ulcère chronique stable versus signes d'alerte nécessitant une prise en charge urgente : infection sévère, ischémie, douleur intense inhabituelle, fièvre, œdème brutal ;
  - l'importance d'un suivi programmé dans des filières spécialisées (médecine vasculaire, centre de plaies) ;
  - la pertinence d'une référence directe vers le spécialiste en absence de signes de gravité.
- Les recommandations précisent des critères et délais :
  - si l'ulcère n'a pas diminué de ~25% en 4 semaines ou ne guérit pas en 12 semaines → orientation vers service spécialisé ;
  - si suspicion d'infection sévère, ischémie critique, douleur majeure, ou signes systémiques → prise en charge urgente/hospitalière.
- cf protocole médecine vasculaire : protocole de prise en charge des infections locales d'ulcère à pyocyanique : expliquant les signes d'infection des ulcères.

Dans cette situation, le patient ne présentait pas d'éléments de gravité, et la demande relevait d'un rendez-vous spécialisé — non d'une urgence.

LES PROTOCOLES

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paul Saint-Joseph

Orientation des patients des urgences vers le Centre de consultation Marie Thérèse et Maison Médicale de Garde Bellan

1URG-PRC-014
Version : 01

Emetteur : Service des urgences	**Date d'application :** 12/01/2022 **Date de création :** 24/11/2015
Rédigée par Dr JL. AIM	signature : JLA
Validée et approuvée par Dr O. GANANSIA	signature : OG

INFORMATIONS GENERALES :

Objet : Modalité d'orientation d'un patient ayant besoin d'une consultation vers le centre de santé Marie Thérèse site Saint Joseph ou la maison médicale de garde Léopold Bellan

Domaines d'application : Service des urgences, Centre de santé Marie Thérèse site Saint Joseph, Maison médicale de garde Léopold Bellan

CONDUITE A TENIR :

Tout patient se présentant aux urgences pour une consultation est inscrit administrativement, avec création d'un dossier.

Le patient est ensuite vu par l'Infirmière Organisatrice de l'Accueil (IOA) qui :

- évalue le niveau de gravité de la situation clinique
- reformule la demande du patient.

Si :
- la demande du patient relève d'une consultation de médecine générale
- les constantes vitales ne révèlent aucune anomalie

A l'exclusion de la traumatologie, des complications post opératoires, de la proctologie, des patients adressés par un médecin

L'IOA peut proposer au patient une orientation :

- Vers le centre de consultation Marie Thérèse du site Saint Joseph en semaine
- La Maison Médicale de Garde Bellan le samedi et dimanche et jours fériés
- Vers le cabinet de télémédecine Teledok en semaine et le samedi.

Avec l'accord du patient ET l'accord du médecin senior responsable des urgences

Un document est remis au patient à l'intention du centre de consultation

Un recueil du nombre de patients adressés vers ces structures est organisé

Une évaluation de la coopération entre les structures est réalisée par une rencontre des équipes au moins une fois par an.

Les patients peuvent être ré-adressés aux urgences si besoin
Un lien téléphonique est possible à chaque moment.

HÔPITAUX Paris — Saint Joseph — Marie Lannelongue

Référence : HPSJMEDVASC-PROT-933

Version : 1

Protocole de prise en charge des infections locales d'ulcère à pyocyanique

Auteur(s) : JAILLETTE Clement, MICHON PASTUREL Ulrique		**Date de création :** 21/04/2022 **Date de modification :** 21/04/2022
Validée par : Ulrique MICHON-PASTUREL, Clément JAILLETTE, Parinaz GHAFFARI	**Fonction** : Médecins vasculaires	**Le** : 21.04.2022
Approuvée par : Carine COUZIGOU	**Fonction** : Infectiologue	**Le** : 21.04.2022

Objet : Protocole de prise en charge des infections locales d'ulcère à pyocyanique (Pseudomonas aeruginosa)

Domaines d'application : Pôle CNVM hospitalisation

Objectif : identifier les situations d'infection locale d'ulcères et éviter la prescription systématique d'antibiothérapie systémique large afin de ne pas favoriser l'antibiorésistance.

Documents associés ou de référence :

- Manuel d'accréditation : Chapitre 2 (prise en charge des patients appartenant à une population spécifique. Réf 19a)
- HAS - Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes. Ann Dermatol Vénéréologie. Oct 2019 ; 146 (10) : 610-25
- International Wound infection Institute (IWII) Infection de plaies dans la pratique clinique. Wounds International. 2022.
- Recommandations HAS. Les pansements – indications et utilisation recommandée. 2010
- Consensus International. Bon usage des pansements à l'argent dans les soins des plaies. London: Wounds International, 2012
- Blech MF, Martin C, Borrelly J, Hartemann P. Treatment of deep wounds with loss of tissue. Value of a 3% boric acid solution. Presse Med. 1990;19(22):1050-2.
- Surinfection de plaie chronique par Pseudomonas aeruginosa. Rev Med Suisse 2015 ; 11 ; 768-72
- World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principes de bonne pratique : L'infection des plaies en pratique clinique. Un consensus international. Londres : MEP Ltd, 2008.

HÔPITAUX Paris — Saint Joseph — Marie Lannelongue

Référence : HPSJMEDVASC-PROT-933

Version : 1

1/ Epidémiologie – risques liés à l'infection

Pseudomonas aeruginosa ou bacille pyocyanique et une bactérie à bacille Gram négatif aérobie strict. Dans la dernière enquête de prévalence des infections associées aux soins organisés par Santé publique France en 2017, Pseudomonas aeruginosa est le 4e germe (6,3 %) responsable d'infections nosocomiales derrière Escherichia coli (23,6%), Staphylocoque aureus (13,8%), Enterococcus faecalis (6,5%).
Les bactéries les plus fréquemment rencontrées lorsque les ulcères sont localement infectés sont : le staphylocoque aureus et les Corynebacteries dans 75 % des cas, le Pseudomonas aeruginosa dans 60 % des cas, les entérobactéries dans 60 %, le streptocoque dans 40 % et les aérobies dans 40 % des cas.
La production rapide et massive des facteurs de virulence pourrait expliquer l'apparition brusque d'une infection aiguë chez un patient jusque-là colonisé par Pseudomonas aeruginosa (c'est-à-dire ne présentant pas de signe clinique ou biologique d'infection).
P. aeruginosa est naturellement résistant à de nombreux antibiotiques. Il est capable de développer de nombreuses résistance soit par l'activation de ses mécanismes intrinsèques soit par l'acquisition de matériel génétique étranger véhiculée par des éléments mobiles (plasmides, transposon). Cette espèce bactérienne fait désormais partie de la liste des bactéries dans la résistance aux antibiotiques est devenu un problème majeur de santé publique.

2/ Les ulcères d'origine vasculaire

Les ulcères de jambe d'origine vasculaire sont des plaies chroniques (trouble trophique évoluant depuis 4 à 6 semaines), à risque élevé d'infection et surviennent chez des patients polypathologiques.
Les facteurs de risque d'infection sont multiples : diabète, immunodépression, hypoperfusion, anémie, obésité, malnutrition, etc...

3/ Les critères d'infection locale d'ulcère (HAS 2019)

Dans le document HAS de 2019 « Prise en charge de l'infection cutanée bactérienne courante », les critères d'infections locales d'ulcère sont :
- Douleurs inhabituelles au niveau ou en périphérie de l'ulcère
- Arrêt de la cicatrisation
- Tissu de granulation friable
- Aggravation de la plaie : augmentation rapide de la taille, de l'exsudat, caractère purulent ou nécrotique
- Signes généraux d'infection (critère justifiant une antibiothérapie)

4/ Prise en charge des infections locales d'ulcères

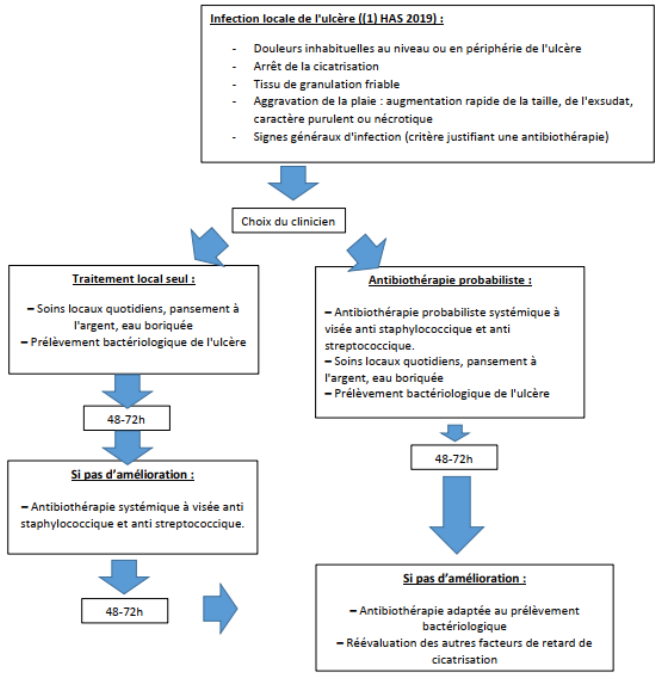
Dans le service de médecine vasculaire du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, la prise en charge des plaies chroniques concerne environ 80 % des patients hospitalisés soit plus de 1000 patients par an. Le diagnostic d'infection locale d'ulcères de jambe est réalisé par les médecins du service, appuyé si nécessaire par l'équipe de médecins infectiologues sur un faisceau d'arguments cliniques (HAS 2019). Des prélèvements locaux à visée bactériologique sont réalisés lors des infections locales d'ulcères avant la mise en place du traitement local ou de l'antibiothérapie probabiliste systémique ciblant le staphylocoque aureus et le streptocoque.
Le protocole est détaillé dans l'algorithme ci-joint.
Dans certaines situations particulières, l'antibiothérapie peut couvrir initialement le Pseudomonas aeruginosa en plus du Staphylocoque et du Streptocoque si l'aspect clinique est en faveur d'une infection systémique à Pyocyanique, après discussion avec les infectiologues.

HÔPITAUX Paris — Saint Joseph — Marie Lannelongue

Référence : HPSJMEDVASC-PROT-933

Version : 1

5. Algorithme[1] :



[1] *Dans certaines situations particulières, l'antibiothérapie peut couvrir initialement le Pseudomonas aeruginosa en plus du Staphylocoque et du Streptocoque si l'aspect clinique est en faveur d'une infection systémique à Pyocyanique, après discussion avec les infectiologues.*

Situation n°2

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

LA SITUATION

- **Présentation succincte de la situation :**
  - Contexte : journée avec un flux continu et intense
  - Localisation : salle d'attente "couchés"
  - En fin d'après-midi

Treize patients occupent la salle d'attente. La zone 2 est complète et tous les brancards sont utilisés. Il n'y a plus de brancards disponibles dans le SAS couché malgré de nombreux appels, Théo et information aux cadres. A l'IOA 1, nous prenons en charge une patiente pour laquelle nous devons aller au SAUV (suspicion d'AVC). Aucun brancard n'est disponible, nous prenons nous-même la décision de verticaliser un patient en zone pour obtenir un brancard en urgence.

LA PROBLEMATIQUE

- **Qu’est-ce qui vous a posé problème ?**

La perte de chance pour la patiente ainsi que la perte de temps pour nous (7 patients en attente de voir l'IOA derrière elle)

- **Qu’est-ce que vous avez mis en place ?**

Verticalisation d'un patient pour avoir un brancard rapidement, alerte des cadres

- **Comment avez-vous pris en charge le patient ?**

Nous avons informé le patient d'une possible attente due à un manque de moyen.

- **Avez-vous mobilisé des ressources humaines, organisationnels, institutionnels, …**

A de multiples reprises (problématique soulevée chaque hiver)

LES ECRITS

- SFMU : "A cet instant, le patient est dirigé de préférence en salle d'accueil des urgences vitales (SAUV)" --> SAUV donc pas d'attente possible, urgence immédiate

https://www.sfmu.org/upload/70_formation/02_eformation/02_congres/Urgences/urgences2008/donnees/pdf/104_cadel.pdf

- HAS : "Le patient est laissé strictement à jeun et au repos strict en décubitus" --> Nécessité de DDS impossible aux vues du manque de moyen

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/avc_param_351dical_recommandations_version_2006.pdf